

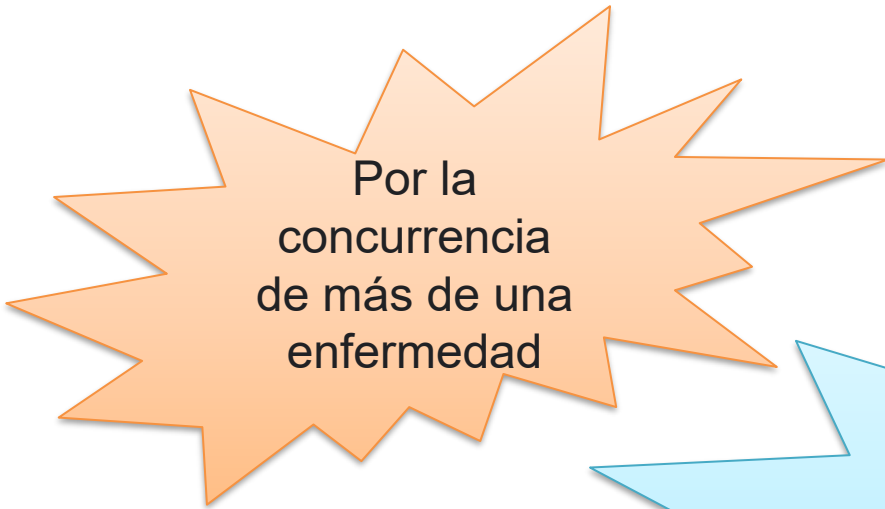
REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación
Lic. Yasmin del Rosario Bruno Phowell

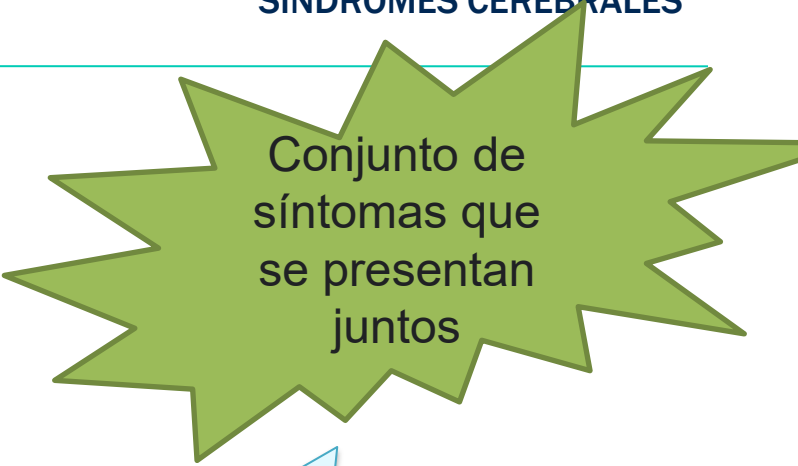
Semana 6:

- Definición:
- Características clínicas
- Síntomas
- Tipos de tratamiento
- Actividad en campus

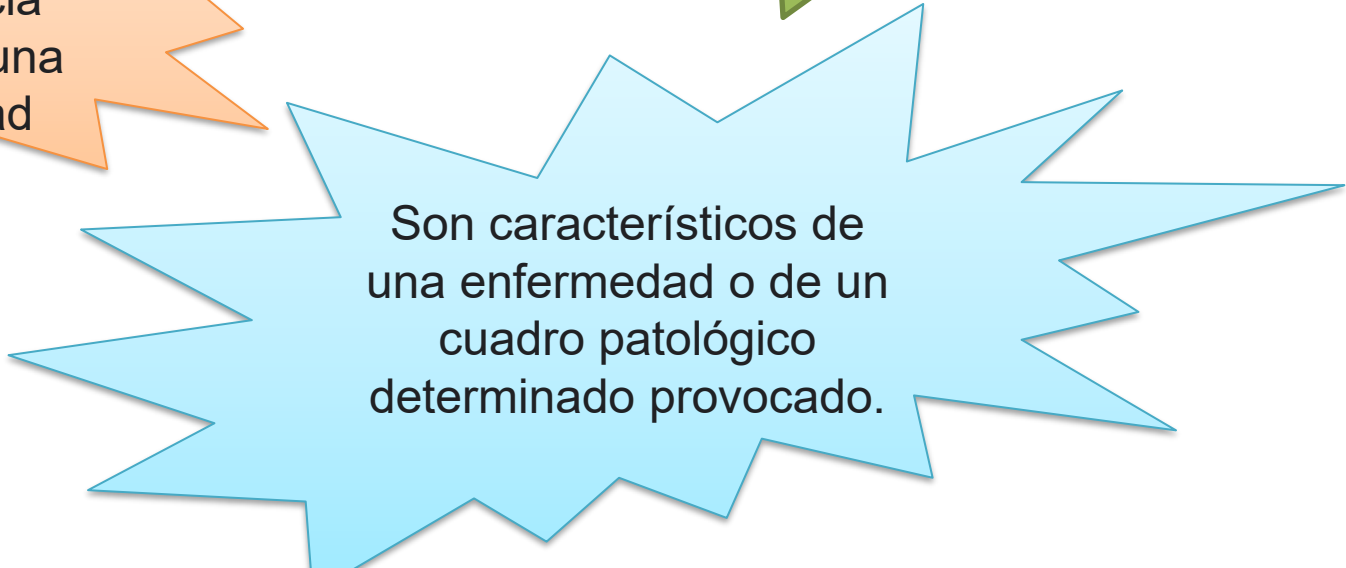
- ¿Qué es un síndrome?



Por la
conurrencia
de más de una
enfermedad



Conjunto de
síntomas que
se presentan
juntos



Son característicos de
una enfermedad o de un
cuadro patológico
determinado provocado.

- ¿Qué es un síndrome neurológico?

Son enfermedades del sistema nervioso central y periférico.

- *‘El síndrome es el conjunto de síntomas y signos que definen una función alterada y que se relacionan entre sí por medio de algún rasgo anatómico, fisiológico o bioquímico peculiar’*
 - Principios de Medicina Interna

GENERALIDADES

- El síndrome es el primer resultado de la síntesis de las manifestaciones del paciente.
- El diagnostico intenta ubicar el origen de los síntomas.
- Los signos brindan la ubicación de varias regiones o de un sistema.
- El nombre del diagnostico se llama: “anatomotopografía o funcional”.

GENERALIDADES

- La identificación de un síndrome se va a considerar los siguientes puntos.
 1. Semiológico:
 1. Se basa en los síntomas que muestra el paciente.
 2. Topográfico:
 1. Se basa en donde se van a ubicar los síntomas.

Tabla I. Clasificación semiológica de los síndromes neurológicos.

Categoría tradicional	Ejemplos de síndromes
Déficit sensitivo	Polineuropático, radicular posterior, cordonal posterior, centromedular, Brown-Séquard, Wallenberg, Déjerine-Roussy, Déjerine-Mouzon, Verger-Déjerine
Cefalea	Hipertensión endocraneal, migraña clásica, migraña hemipléjica, migraña oftalmopléjica, cefalea tensional, disfunción de la articulación temporomandibular, irritación meníngea (meningitis aséptica, hemorragia subaracnoidea), posconmocional
Debilidad muscular	Motoneuronopatía superior, motoneuronopatía inferior
Hemiplejía	Hemiparesia motora pura, hemiparesia atáxica, Weber, Foville superior, Millard-Gübler, Foville inferior, Raymond-Cestan
Paraplejía	Mielopatía ventral, mielopatía sensitivomotora transversal aguda
Epilepsia	Encefalopatía mioclónica neonatal, encefalopatía epiléptica neonatal, epilepsia mioclónica benigna de la infancia, epilepsia mioclónica refleja de la infancia, epilepsia mioclónica infantil familiar, West, Lennox-Gastaut, ausencias con mioclonías palpebrales, epilepsia mioclonicoastática, epilepsia-ausencias mioclónicas, epilepsia mioclónica juvenil, convulsiones neonatales familiares benignas, convulsiones neonatales benignas, encefalopatía epiléptica infantil precoz, epilepsia-ausencias infantil, epilepsia-ausencias juvenil, epilepsia con crisis tónicoclónicas generalizadas en el niño, epilepsia con crisis tónicoclónicas generalizadas de la adolescencia o gran mal del despertar, convulsión febril simple y complicada

Ataxia	Cerebeloso estático, cerebeloso cinético, cerebeloso cinético bilateral, vestibular, ataxia frontal
Pérdida visual o ceguera	Amaurosis fugaz, neuropatía óptica retrobulbar, neuropatía óptica distal, Foster-Kennedy, Anton
Oftalmoplejía externa	Nothnagel, Benedikt (peduncular posterior), Weber (peduncular anterior), esfenocavernoso, Tolosa-Hunt, Foville superior, Foville inferior, Millard-Gübler, Raymond-Cestan
Oftalmoplejía interna	Argyll-Robertson, Weber, pupila tónica de Adie, Pourfour du Petit, Horner
Deterioro de conciencia	Confusión mental, delirio, estupor, coma, <i>locked-in</i> ('del encerrado'), catatonía, abulia, vegetativo y pseudocomas (dismetafunción encefálica), muerte cerebral
Afasia	Afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia motora transcortical, afasia sensorial transcortical, afasia transcortical mixta, afasia nominal (amnésica), afasia global
Alteraciones neuropsíquicas	Depresión, ansiedad, amnesia, demencia, esquizofrenia, abstinencia alcohólica, dependencia alcohólica, posconmocional

Tabla II. Clasificación topográfica de los síndromes neurológicos.

Categoría tradicional	Ejemplos de síndromes
Cerebral difuso	Confusión mental, delirio, coma, demencia
Lóbulo frontal	Frontal dorsolateral, orbitofrontal, apático-abúlico, ataxia frontal de Bruns, afasia de Broca, motoneuronopatía superior, parálisis pseudobulbar
Lóbulo temporal	Afasia de Wernicke, afasia anómica, agnosia verbal auditiva
Lóbulo parietal	Verger-Déjerine, Déjerine-Mouzon, Anton-Babinski, Gerstmann
Lóbulo occipital	Anton, Balint, ceguera pura para las palabras, Bonnet
Tálamo	Déjerine-Roussy, sensitivo queiro-oral
Hipotálamo	Hipotalámico global, diabetes insípida, secreción inadecuada de ADH, Cushing, pubertad precoz, Froehlich
Cápsula interna	Hemiparesia motora pura, déficit hemisensitivo puro
Cerebelo	Cerebeloso cinético, cerebeloso estático

Estriado-subtálamo	Parkinson, coreoatetosis
Mesencéfalo	Weber, Claude, Benedikt, Nothnagel, Parinaud
Protuberancia anular	Millard-Gübler, Raymond-Cestan
Bulbo raquídeo	Avellis, Jackson, Wallemberg
Médula espinal	Brown-Séquard, centromedular, medulopatía ventral, cordonal posterior, radiculocordonal posterior
Meninges y líquido cefalorraquídeo	Irritación meníngea (meningitis aséptica, hemorragia subaracnoidea), hipertensión endocraneal, Froin

Nervios craneales múltiples	Esfenocavernoso, espacio petroesfenoidal (Jacob), vértice del peñasco (Gradenigo-Lannois), ángulo pontocerebeloso, agujero rasgado posterior (Vernet), espacio esternocondíleo posterior (Collet-Sicard), espacio retroparotídeo posterior (Villaret), base de cráneo (Garcin)
Raíz espinal	Monorradiculopatía, (C ₅ , C ₆ , C ₇ , L ₄ , L ₅ , S ₁), lesión de la cola de caballo
Plexo	Plexopatía braquial superior, plexopatía braquial inferior, plexopatía braquial completa, plexopatía lumbosacra
Nervios periféricos	Mononeuropatía (motor ocular común, troclear, motor ocular externo, facial, axilar, cubital, mediano, radial, ciático, peroneo tibial posterior, femoral), mononeuropatía múltiple, polineuropatía (sensitiva, motora, autonómica, mixta), polirradiculoneuropatía

GENERALIDADES

- Los síndromes neurológicos de observación más frecuente en la clínica son:
 - 1. Síndromes motores.
 - 2. Síndromes sensitivos.
 - 3. Síndromes del tallo cerebral.
 - 4. Síndrome cerebeloso.
 - 5. Síndrome meníngeo.
 - 6. Síndrome de hipertensión endocraneana.
 - 7. Síndrome comatoso.

TRATAMIENTO

- **OBJETIVOS:**
- Centra su actividad en mejorar la movilidad del paciente.
- Crea nuevas rutas neurológicas
- Refuerza las ya existentes para que el movimiento tenga lugar.
- Es necesario conocer e identificar las características y necesidades de cada paciente.

Muchas gracias



Presente.